

RADIOLOGÍA INTERVENCIONAL DE URGENCIA

Nº	PROYECTOS	HOSPITAL A CARGO	ALCANCE	PRESTACIONES	CRITERIOS DE LLAMADO	ACTIVACIÓN DE LLAMADA	FIRMA CERTIFICADOS
3	RADIOLOGÍA INTERVENCIONAL DE URGENCIA	CASR	Todo paciente pediátrico y adulto red sur oriente	1) Angioembolización	Hemorragias agudas de origen traumático y no traumático en los segmentos torácico, abdominal, pelvis y extremidades susceptibles de tratamiento endovascular y que no puedan ser resueltas a través de cirugía o esta última pueda aumentar la morbilidad del paciente respecto a la embolización.	*Médico jefe de turno de Cirugía UEH Adultos del CASR *Coordinador de la Unidad de Trauma y Urgencia (UTU) de turno del CASR.	Jefe Servicio clínico Cirugía Adultos del CASR

❖ Los requerimientos para realizar la activación serán:

- Hemodinamia estable.
- AngioTAC (< 24 horas) que demuestre sangrado activo en órgano afectado.
- En pacientes que ingresen con inestabilidad hemodinámica, se deberá realizar cirugía de control de daños previo a la activación de Radiología Intervencional.
- Disponibilidad de Recursos intrahospitalario.

❖ Es importante que cada vez que se presente un paciente con necesidad de procedimiento por parte de este equipo de especialistas, se comunique vía correo electrónico y teléfono, la necesidad al equipo de Gestión del Camas del CASR, es fundamental este paso para las gestiones de derivación, asignación de cama si corresponde o retorno del usuario a su Hospital Base.



- ❖ Posterior al procedimiento y según condición clínica, los pacientes con trauma grave se trasladarán a unidad de agudo quirúrgico o unidad de paciente crítico. Posterior a 48-72 horas si la condición hemodinámica lo permite, será retornado a su hospital de base de manera coordinada entre los equipos de Gestión de Camas.
- ❖ En los casos de pacientes no traumáticos, el consultor de la llamada definirá si se encuentra en condiciones de retorno a su hospital base, en casos correspondientes a HPH y HLF, registrando en la ficha o documento del procedimiento “pertinencia de retorno”, de lo contrario Gestión de Camas del CASR deberá asignar cama en CASR, hasta que se encuentre en condiciones de retorno.
- ❖ El retorno a hospital base debe asegurarse a una cama hospitalaria, según requerimientos del paciente y disponibilidad. Es importante que el Hospital Base asegure una cama para recepción del paciente desde CASR, gestión que debe iniciar Hospital Base desde el momento que presenta inicialmente el paciente al CASR.

TELÉFONOS CASR

AREA	TELÉFONO	RED MINSAL
ESTACIÓN DE ENFERMERÍA	2 2576 2662	262662
	2 2576 2363	262363
REANIMADOR UEH ADULTOS	2 2576 2353	262353
MÉDICO COORDINADOR UEH ADULTOS	9 9998 0214	
NEURÓLOGO DE TURNO	9 4448 1955	
NEUROCIRUJANO DE TURNO	2 2576 2284	262284